

SALUTE MENTALE

Responsabile del modulo

Lorenzo Pezzoli

Psicologo e psicoterapeuta FSP

Cinzia Campello

Psicologa FSP

Elisa Milani

Psicologa e psicoterapeuta FSP

Natalia Perucchi

Campopiano

Psicologa e psicoterapeuta FSP

Paola Blumer

Psicologa e psicoterapeuta FSP

Alessia Ceroni

Docente assistente

"Gli individui alessitimici mostrano una sorprendente difficoltà a riconoscere e descrivere i loro sentimenti e a discriminare tra stati emotivi e sensazioni corporee; a volte hanno esplosioni di collera e di pianto, ma quando vengono interrogati a riguardo sono incapaci di elaborare ulteriormente quello che provano. Essi tendono a utilizzare l'azione per esprimere emozioni o per evitare conflitti e sperimentano povertà di sogni e fantasia. Il funzionamento emotivo e la vita psichica interna così ridotti sono rivelati spesso dalla rigidità posturale e dalla mancanza di movimenti espressivi del volto." (Baiocco, Giannini, Laghi, 2005, pag. 8)

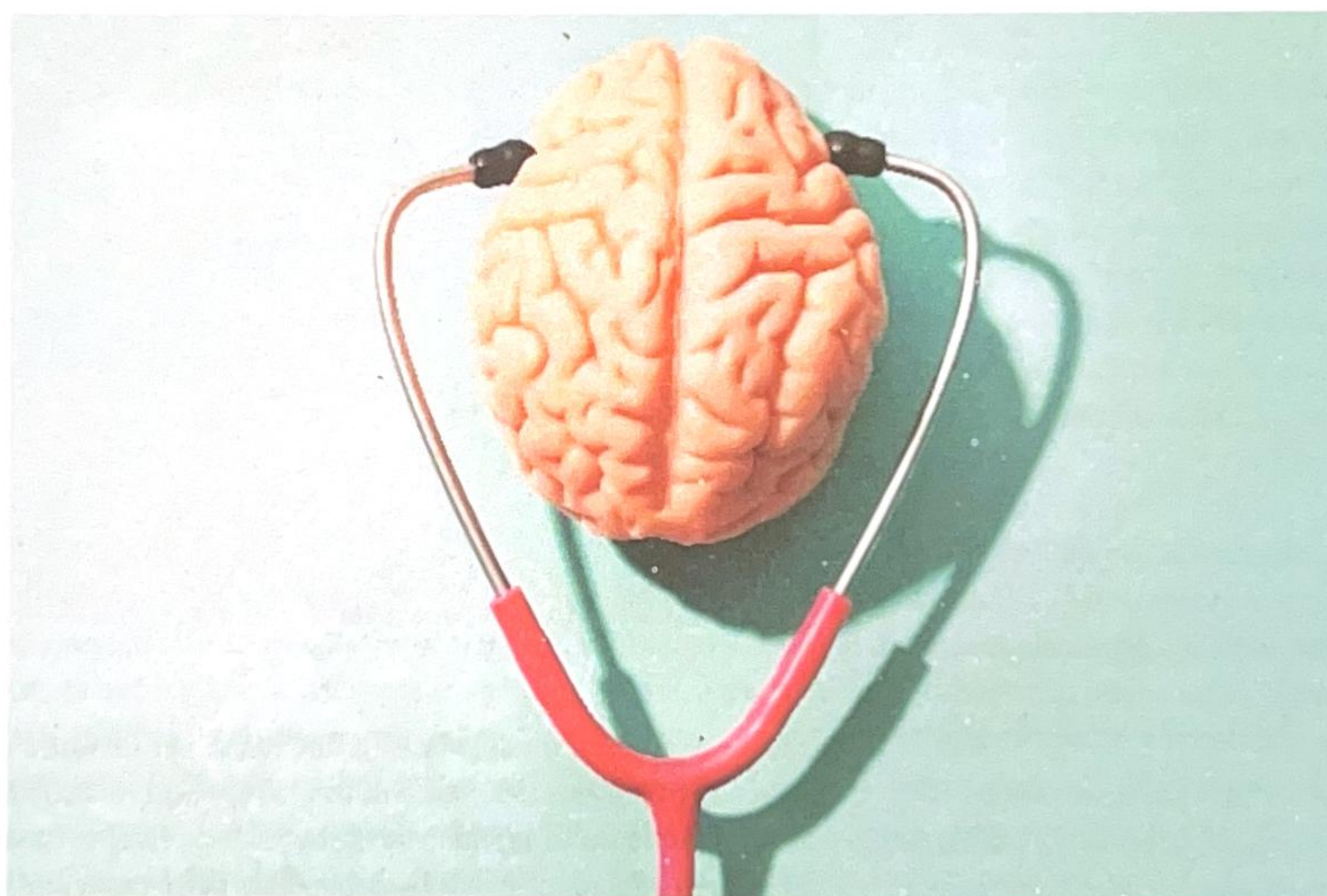


Immagine Microsoft

Cara studentessa, caro studente,

il costrutto di alessitimia di cui andremo a parlare in questo seminario è un costrutto piuttosto giovane. Malgrado ciò, vedremo come negli ultimi anni siano stati fatti numerosi studi per meglio comprendere questo fenomeno. Con il termine di alessitimia ci si riferisce a un'incapacità della persona a dare un nome alle proprie emozioni, anche se vedremo che il costrutto di alessitimia è un qualcosa di ben più complesso. Come sottolineato da Zappa et al. (2011), diversi studi clinici sono arrivati alla conclusione che il costrutto dell'alessitimia appartenga all'area della disregolazione degli affetti. Per capire questo costrutto dobbiamo dunque tornare a parlare di emozioni e in modo particolare della loro espressione, del loro riconoscimento e della loro regolazione. Se in passato veniva ritenuto che l'alessitimia fosse una caratteristica di pazienti che soffrivano di una patologia psicosomatica, oggi la letteratura è

concorde nel ritenere che da un punto di vista nosografico essa sia da considerare come un costrutto transnosografico.

L'alessitimia è infatti stata studiata e riscontrata anche nell'ambito delle tossicodipendenze, dei disturbi del comportamento alimentare, nei traumi, nelle perversioni sessuali, in relazione alle sindromi affettive, ma anche ad altre sindromi. Come potete ben capire dunque, il tema è vasto ed articolato e ci permetterà di fare riferimento a molti dei temi trattati durante il modulo di Salute mentale. Ci limiteremo tuttavia in questo capitolo, dopo aver definito il costrutto di alessitimia, compreso la sua possibile eziologia e le manifestazioni nella vita quotidiana, a declinarlo in relazione al concetto di trauma e alle dipendenze patologiche.

Cinzia Campello

La regolazione affettiva

Cinzia Campello

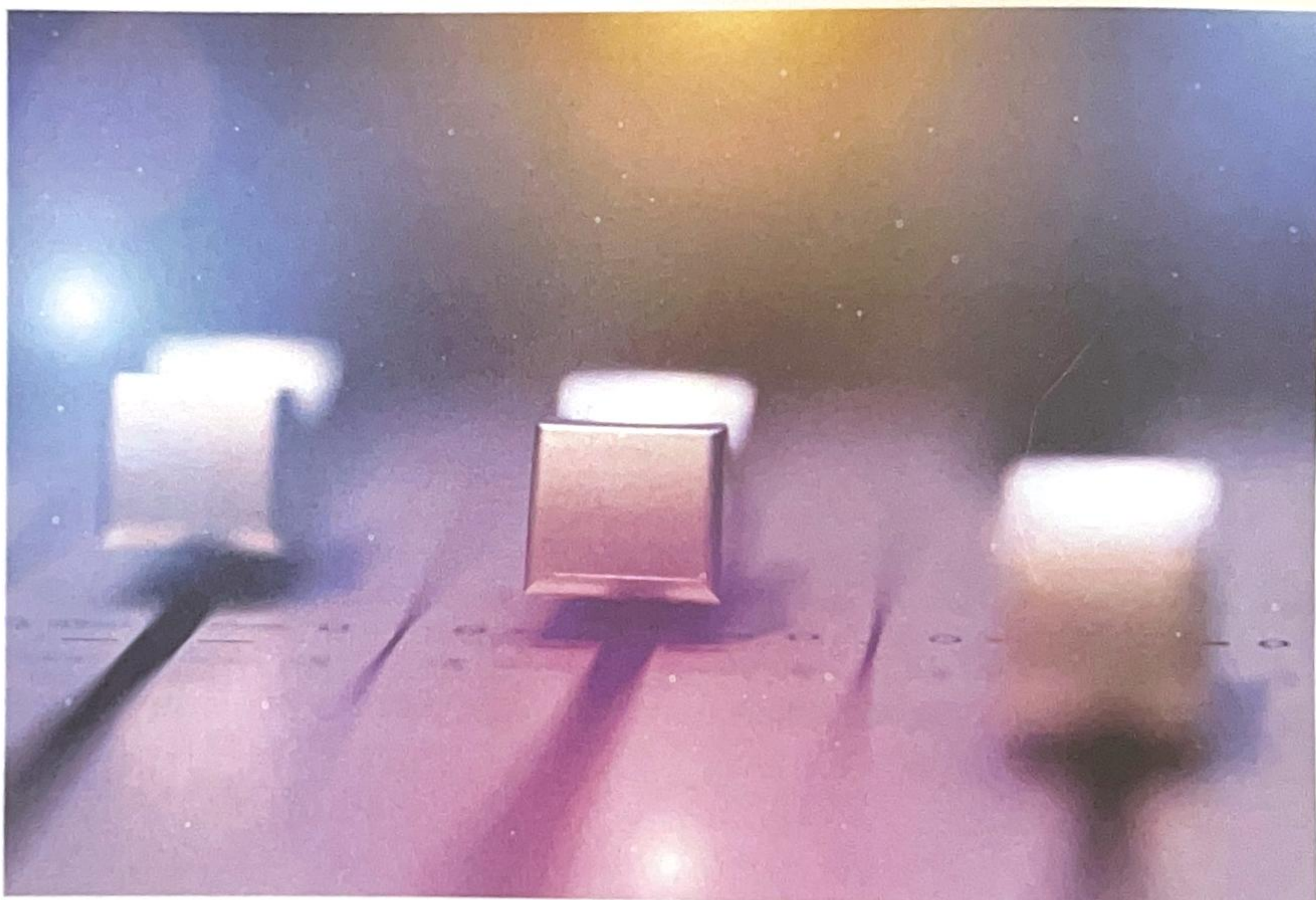


Immagine Microsoft

“[...] le emozioni che noi sperimentiamo e mostriamo sono già l'esito di un processo, in gran parte inconsapevole, di autoregolazione, che ne modula la natura, l'intensità e le manifestazioni.”

(Matarazzo O., Zammuner V. L., 2015, p.9)

Le emozioni sono fondamentali e funzionali per la nostra sopravvivenza e per il mantenimento delle nostre relazioni sociali. Studiare la regolazione delle emozioni significa chinarsi a riflettere su un argomento di grande rilevanza anche a livello educativo. In questo capitolo andremo a interrogarci sul significato di regolazione delle emozioni, sull'importanza di tale regolazione, ma anche su come impariamo a regolare le nostre emozioni.

Abbiamo già detto nelle precedenti lezioni che molte sono le teorie sulle emozioni e molte sono anche le teorie che riguardano la regolazione degli affetti. Non ci è possibile qui entrare nel merito di queste teorie in modo esaustivo, ma prenderemo spunto da alcune di esse per riflettere sulla loro importanza e sulla loro complessità.

Già Aristotele si era interrogato su tali dimensioni sostenendo che i nostri affetti potrebbero risultare dannosi se non moderati. Egli aveva sottolineato come regolare gli affetti significasse secondo lui *“fare in modo che essi si estrinsechino tra gli estremi dell'eccesso e della scarsità”*. (Fonagy et al., 2005, p. 25). Sempre secondo Aristotele è possibile apprendere a regolare i propri affetti, una visione messa invece in discussione dai filosofi stoici che ritengono che l'essere umano deva prendere distanza dalle emozioni sulle quali non può avere controllo e agire dunque sulla base della razionalità. (Fonagy et al., 2005)

Anche tra gli psicologi sono emerse diverse teorie in merito alla regolazione affettiva. La stessa teoria di Ekman sulle emozioni fondamentali – di cui abbiamo parlato nella lezione sulle sindromi affettive e le sindromi ansiose – non è stata condivisa da tutti. Tra coloro che non condividono tale teoria troviamo per esempio Shweder secondo il quale alcune emozioni non sono ricollegabili a delle espressioni caratteristiche sul volto della persona. (Fonagy et al., 2005)

Molti sono gli studiosi che si sono chinati a studiare e ad approfondire la regolazione affettiva. Un elemento importante che viene ripreso riguarda la contestualizzazione culturale.

Non stessi non esprimiamo le emozioni allo stesso modo in qualsiasi momento e in qualsiasi contesto. Le emozioni vengono in parte regolate in modo inconscio e in parte consapevolmente. Per fare questo dobbiamo però essere coscienti di ciò che stiamo provando, consapevolezza che viene acquisita in modo progressivo durante lo sviluppo. Grazie alla disponibilità emotiva della figura del caregiver il bambino potrà in modo progressivo imparare a verbalizzare le proprie emozioni e di conseguenza desomatizzarle. L'apprendimento della regolazione delle emozioni da parte del bambino avviene infatti in gran parte grazie alla relazione con il caregiver. Progressivamente il bambino acquisisce la capacità di simbolizzazione e tramite il linguaggio impara a dare un nome agli stati affettivi che vive. Se da una parte il caregiver regola inizialmente gli affetti del bambino, egli tramite la manifestazione di questi affetti influisce a sua volta sul comportamento assunto dal caregiver. Secondo alcuni studi, i diversi tipi di attaccamento sarebbero da ricondurre a diverse strategie di regolazione degli affetti (Caretto, V. & La Barbera, D., 2005).

Fin da piccoli apprendiamo a regolare o modulare le emozioni che proviamo per esempio nella loro intensità. Ciò non significa reprimere ciò che proviamo, ma esprimerlo in modo congruo alla situazione (Matarazzo, O. & Zammuner, V. L., 2015). Per esempio, se riceviamo una bella notizia che ci dà gioia e accanto a noi c'è un nostro amico che ne ha ricevuta una brutta, non esulteremo per non mancargli di rispetto. Ciò fa parte delle norme sociali che ci vengono insegnate. La regolazione delle emozioni non solo riconduce dunque all'educazione ma anche alla cultura di appartenenza, può essere funzionale non solo all'adeguarsi alle norme sociali, ma anche a conseguire i propri interessi, mantenere le relazioni e la propria autostima. I motivi che ci portano alla regolazione affettiva possono dunque essere molteplici.

Diversi autori hanno sottolineato come esista non solo un'intelligenza intellettiva comunemente chiamata Q.I., ma anche un'intelligenza emotiva che viene denominata Q.E. Molti autori si sono interessati alle diverse forme di intelligenza. Salovey e Mayer dopo aver elaborato nel 1990 una prima definizione di intelligenza emotiva, l'hanno rivalutata rielaborando una nuova definizione articolandola nel modo seguente: *“l'intelligenza emotiva coinvolge l'abilità di percepire, valutare ed esprimere un'emozione, l'abilità di accedere a sentimenti e/o crearli quando facilitano i pensieri, l'abilità di capire l'emozione e la conoscenza emotiva e l'abilità di regolare le emozioni per promuovere la crescita emotiva e intellettuale”* (Zappa L. E. et al, 2011, p.68). Secondo questi autori questa forma di intelligenza è caratterizzata da sedici diverse abilità da loro suddivise in quattro categorie che a loro volta ci rimandano alla definizione sopra riportata. Queste categorie richiedono processi cognitivi viepiù complessi che possono essere raggiunti progressivamente nel corso dello sviluppo della persona.

Le quattro categorie descritte da Salovey e Mayer sono le seguenti e per ognuna vengono riportate anche le quattro capacità specifiche (riprese dallo schema in Zappa L. E. et al, 2011, pp.68-69):

1. Percezione, valutazione ed espressione delle emozioni
 - 1.1 Capacità di identificare le proprie emozioni ponendo l'attenzione alle modificazioni del proprio corpo, ai vissuti, ai pensieri
 - 1.2 Capacità di identificare le emozioni nelle altre persone e nelle raffigurazioni visive
 - 1.3 Capacità di esprimere le emozioni e i bisogni che ci comunicano in modo appropriato

**Definizione di
Intelligenza emotiva
secondo Salovey e Mayer**

“L'intelligenza emotiva coinvolge l'abilità di percepire, valutare ed esprimere un'emozione, l'abilità di accedere a sentimenti e/o crearli quando facilitano i pensieri, l'abilità di capire l'emozione e la conoscenza emotiva e l'abilità di regolare le emozioni per promuovere la crescita emotiva e intellettuale.”

Zappa L. E., Caslini M.,
Clerici M. (2011, p.68)

- 1.4 Capacità di discriminare tra espressioni delle emozioni appropriate e inappropriate e tra sincere insincere
2. Facilitazione emozionale del pensiero
 - 2.1 Capacità di lasciare che le emozioni svolgano la propria naturale funzione: rendere prioritario un pensiero dirigendo l'attenzione su informazioni importanti
 - 2.2 Capacità di generare volontariamente le emozioni come aiuto ai processi decisionale, di giudizio e di memoria
 - 2.3 Capacità di contrastare lo stato emotivo problematico, prendendo in considerazione molteplici punti di vista
 - 2.4 Capacità di evocare stati emotivi per poter favorire un approccio differenziato ai problemi specifici
3. Comprensione e analisi delle emozioni e regolazione degli affetti
 - 3.1 Capacità di dare un'etichetta verbale alle emozioni e riconoscere la relazione tra parole e le stesse emozioni
 - 3.2 Capacità di interpretare i significati che le emozioni ci comunicano nelle situazioni relazionali
 - 3.3 Capacità di comprendere le emozioni complesse, ossia la possibile compresenza di sentimenti contrapposti
 - 3.4 Capacità di riconoscere possibili transizioni tra diverse emozioni
4. Regolazione consapevole delle emozioni
 - 4.1 Capacità di mantenere aperta la possibilità di provare emozioni, sia piacevoli, sia spiacevoli
 - 4.2 Capacità di rimanere "dentro" l'emozione o di prenderne le distanze, in modo consapevole e sulla base di quanto si ritenga essere utile
 - 4.3 Capacità di monitorare le emozioni riguardanti sia sé stessi, sia gli altri
 - 4.4 Capacità di gestire le emozioni in sé stessi e negli altri, mostrando quelle negative e mantenendo quelle positive, senza ridurne o amplificarne l'importanza.

Non abbiamo qui la possibilità di approfondire questa teoria, ma questa suddivisione articolata in molteplici capacità suddivise a loro volta in diverse categorie ci permette di riflettere sulla complessità del tema della regolazione degli affetti e mette in evidenza la relazione che esiste tra l'ambiente in cui ci troviamo e questi processi regolativi. Avremo in seguito anche modo di riprendere il tema della regolazione intersoggettiva delle emozioni, un aspetto di rilevanza anche per il lavoro educativo.

Il costrutto di alessitimia

Cinzia Campello

Non sempre ci è facile spiegare le emozioni che proviamo e riferire di ciò che sentiamo nel nostro profondo. Per alcune persone, tuttavia, questo avviene nella maggior parte del tempo, stiamo parlando di persone che hanno un funzionamento di tipo alessitimico. Tale difficoltà si ripercuote poi nella quotidianità e nelle relazioni con altre persone. Per l'essere umano gli affetti sono di fondamentale importanza non solo per la sopravvivenza, ma anche per l'adattamento all'ambiente e per le relazioni sociali. Oggi molti autori sono concordi sul fatto che l'alessitimia sia da ricondurre ad un problema di disregolazione delle emozioni.

Una ricerca recente - *Why is alexithymia a risk factor for affective disorder symptoms? The role of emotion regulation* - condotta da Preece D.A. et al (2022), per esempio, è proprio stata

incentrata su tali dimensioni. L'ipotesi sulla quale gli autori hanno basato la loro ricerca è che l'alessitimia sia associata a sintomi di disturbo affettivo a causa dell'effetto compromettente dell'alessitimia sulla regolazione delle emozioni. Come ricordano questi autori nella parte introduttiva della loro pubblicazione, per definizione l'alessitimia compromette la capacità di valutare le emozioni portando la persona a viverle in modo indifferenziato e di conseguenza tale persona ha delle informazioni meno accurate che rendono meno efficace la regolazione delle emozioni. Tra i diversi risultati di questo studio è emerso che i dati ottenuti sono coerenti con le teorizzazioni contemporanee secondo le quali l'alessitimia è collegata ai sintomi del disturbo affettivo attraverso gli effetti negativi dell'alessitimia sulla regolazione delle emozioni. Gli autori stessi hanno sottolineato, tuttavia, un limite a questo studio ovvero il fatto che i dati sono stati rilevati tramite sondaggio online, self-report e trasversale spiegando che sarebbe utile in futuro poter svolgere invece uno studio di tipo longitudinale.

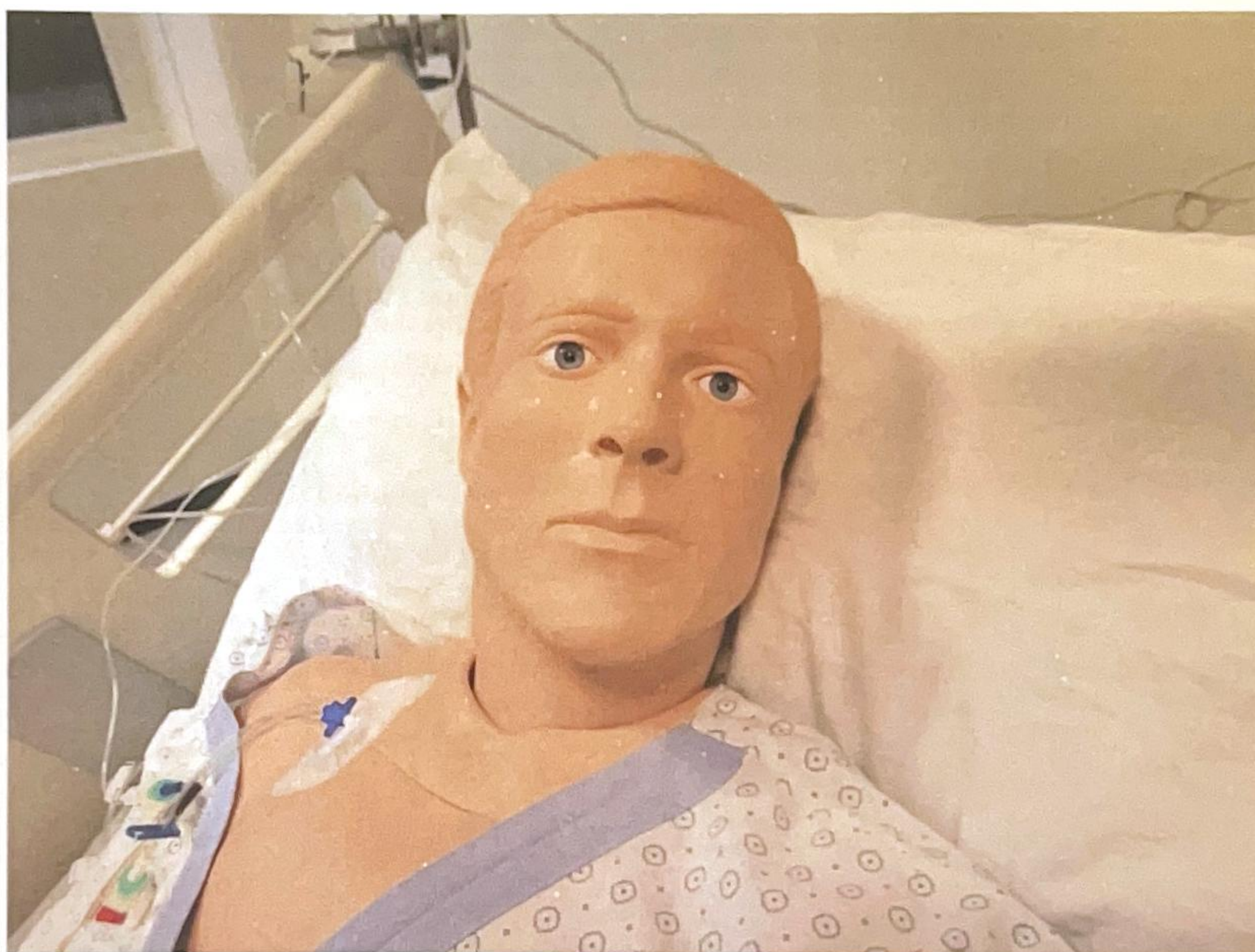
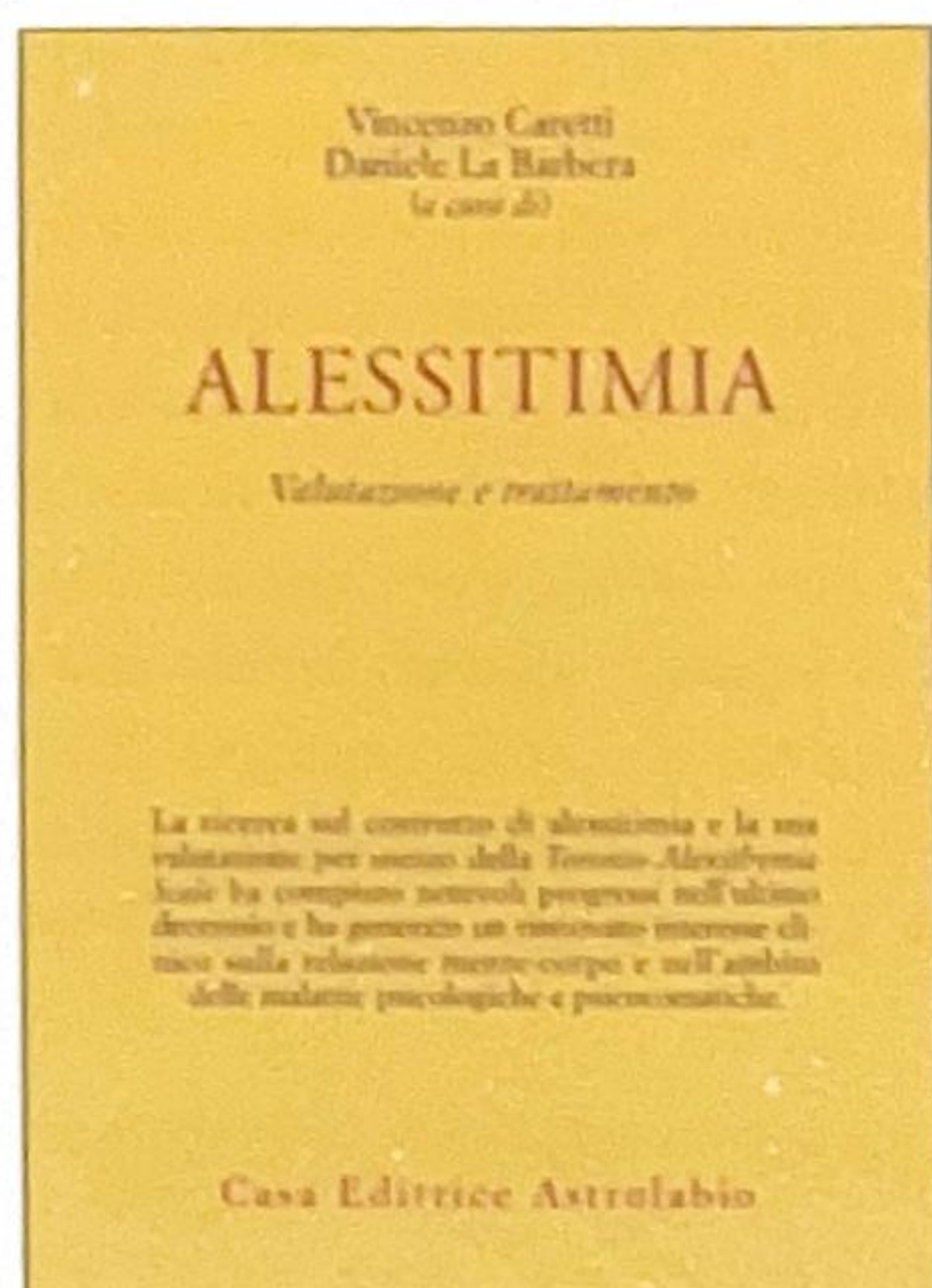


Foto Cinzia Campello

Ma cosa si intende più nello specifico quando si parla di alessitimia? Il costrutto dell'alessitimia è stato definito di recente, negli anni '70 del secolo scorso ed è inizialmente stato incentrato su pazienti che soffrivano di disturbi psicosomatici. Lo studio di certi tratti di persone che soffrivano di tali disturbi è tuttavia iniziato molto prima.

Ruesch, uno psichiatra di origini svizzere poi trasferitosi a San Francisco, aveva pubblicato nel 1948 un testo in cui spiegava di persone che da un punto di vista dell'età cronologica si trovavano nella fase di vita dell'adulthood ma mostravano una personalità infantile che si caratterizzava per un deficit o un'assenza di espressione simbolica degli affetti a favore di un'espressione dei conflitti attraverso l'azione concomitante con la comparsa di disturbi somatici. MacLean, un pioniere della medicina psicosomatica, nel 1949 ha invece sostenuto la difficoltà o l'incapacità dei pazienti con disturbi psicosomatici a esprimere verbalmente le proprie emozioni. Marty e M'Uzan, clinici della scuola di psicosomatica di Parigi nel 1963 hanno invece definito il concetto di pensiero operatorio caratterizzato da un modo di pensare utilitaristico e assenza di fantasia. Questi studiosi descrivono pazienti che sembrano essere testimoni piuttosto che attori della propria esistenza. (Luminet, O. et al. 2013).

Gli studi più recenti hanno poi riscontrato l'alessitimia non solo nei disturbi psico-somatici, ma anche nei disturbi del comportamento alimentare, nelle tossicodipendenze, nelle perversioni sessuali, a seguito di gravi traumi e in alcune malattie somatiche (Lalli N., 2005). Essa viene



riscontrata a livello trasversale in tutti i quadri nosografici caratterizzati da condotte agite e impulsi non controllati (Zappa L. E., et al. 2011).

Il termine è stato coniato nel 1973 da Peter Sifneos, psichiatra e professore alla facoltà di medicina della Harvard, e deriva dal greco. Esso si compone di tre elementi: *a* che riconduce alla mancanza, *lexis* alle parole e *thymus* che significa emozione. L'alessitimia rappresenta dunque una incapacità di esprimere verbalmente le proprie emozioni (Baiocco R. et al., 2005).

Come sottolineato da Taylor et al. nel 1997, l'alessitimia si caratterizza per i seguenti aspetti:

- *difficoltà a discriminare le emozioni le une dalle altre e distinguerle dalle sensazioni somatiche*
- *un vocabolario emotivo limitato, che comporta una notevole difficoltà a comunicare verbalmente le proprie emozioni agli altri*
- *attività fantasmatica deficitaria o assente*
- *uno stile cognitivo orientato verso l'esterno.* (Taylor G.J. et al., 2014, p.78).

Siccome l'aspetto centrale che caratterizza questo costrutto risiede nella difficoltà di regolare le proprie emozioni e comunicarle all'altro, le persone alessitimiche mostrano inoltre difficoltà empatiche, rigidità nella postura, povertà nell'espressione facciale e tendono al passaggio all'atto piuttosto che all'autoriflessione (Baiocco R et al., 2005).

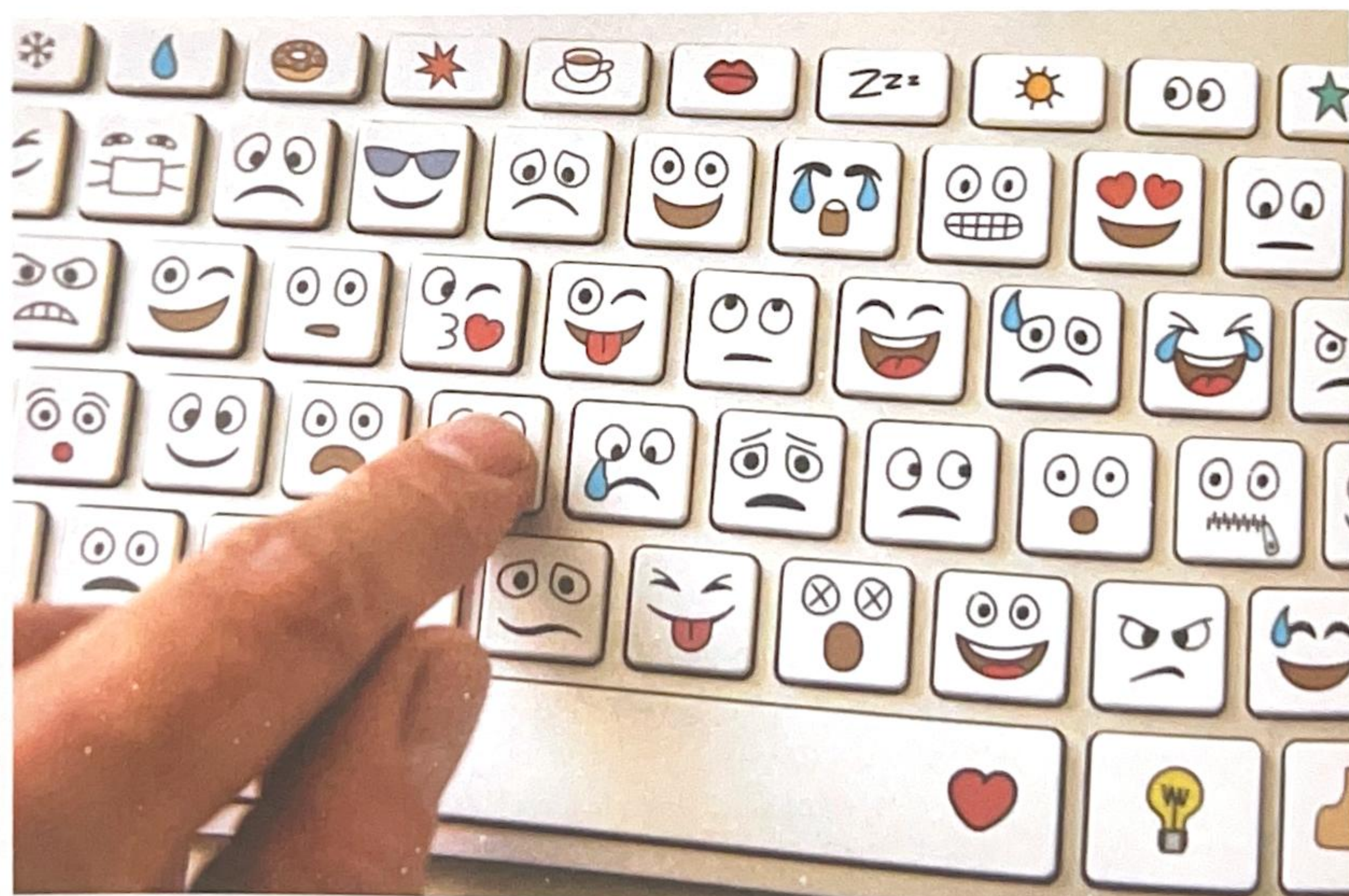


Immagine Microsoft

Queste persone generalmente sono ben adattate e spesso ottengono anche buoni risultati sul lavoro. Esse appaiono tuttavia distanti, poco empatiche e il loro comportamento tende a far assumere una modalità relazionale distante anche ai loro interlocutori. I pazienti affetti da alessitimia presentano inoltre una scarsa attività onirica, raramente riescono a ricordare quanto hanno sognato ma quando riescono a ricordare il sogno a livello affettivo esso è spesso caratterizzato da crudeltà agita o subita (Levitan citato in Lalli N., 2005).

Vista la trasversalità nosografica del costrutto dell'alessitimia e il conseguente interesse, sono state svolte negli ultimi anni diverse ricerche nelle quali sono anche stati utilizzati diversi strumenti di misurazione come, ad esempio, la TAS-20 (Toronto Alexithymia Scale), la SAR (Scala Alessitimica Romana) e la TSIA (Toronto Structured Interview for Alexithymia). Si tratta di strumenti clinici validati per la misurazione di diverse variabili di questo costrutto.

La TAS-20 è nata grazie al lavoro di Graeme Taylor e il suo gruppo di ricerca per la necessità di poter validare il costrutto di alessitimia tramite prove empiriche. Si tratta in un questionario di autovalutazione che, come si evince dal nome, comprende 20 items. Le risposte fornite dalla persona riportano alle dimensioni che definiscono il costrutto di alessitimia ovvero la difficoltà a identificare i sentimenti, la difficoltà nel comunicare i sentimenti agli altri e il pensiero orientato all'esterno o pensiero operatorio. (Caretto V. & La Barbera D., 2005).

La TAS-20 è uno strumento molto utilizzato nell'ambito della ricerca e validato in diverse lingue. In uno studio del 2020 - Twenty-five years with the 20-item Toronto Alexithymia Scale – condotto da Bagby, R.M et al. è stata rivista la letteratura psicometrica che valuta vari aspetti dell'affidabilità e della validità della TAS-20 ed esamina alcune delle controversie che circondano la scala e il costrutto valutato. In questo studio è inoltre stata fatta una riflessione sui modi in cui la TAS-20 ha fatto progredire la misurazione del costrutto e della teoria sull'alessitimia così come sui possibili sviluppi futuri. Dai risultati ottenuti gli autori hanno concluso che, sulla base dell'evidenza empirica accumulata in 25 anni, la TAS-20 è uno strumento affidabile e valido e riflette accuratamente il costrutto dell'alessitimia così come è stato originariamente definito da Nemiah et al. nel 1976. I clinici e i ricercatori possono dunque utilizzare la TAS-20 per misurare con sicurezza l'alessitimia.

Numerosi studiosi si sono inoltre interrogati sull'origine di questo disturbo. Inizialmente, Sifneos aveva attribuito all'alessitimia un'eziologia biologica ed ereditaria. Oggi la maggior parte degli autori riconosce l'alessitimia come strettamente legata allo sviluppo affettivo in fase infantile.

Nel testo di Luminet O. (2013) vengono descritti diversi possibili modelli esplicativi dell'alessitimia tra i quali troviamo per esempio:

- l'ipotesi psicodinamica
- lo sviluppo emozionale
- la presenza di distorsioni di traduzione, di rappresentazione e di interpretazione dello stato emozionale
- la conseguenza di un trauma psichico
- aspetti genetici e
- il funzionamento cerebrale.

Alessitimia e trauma

Cinzia Campello

Come precedentemente accennato, alcuni studiosi si sono interrogati in merito all'eziologia dell'alessitimia e la maggior parte di loro ritiene che essa sia conseguenza di un arresto nello sviluppo affettivo infantile. Lo psicanalista polacco Henry Krystal ritenne che questo arresto fosse conseguenza di un trauma subito dal bambino. Il trauma secondo questo autore influisce nello sviluppo affettivo e in particolare sui processi di desomatizzazione e di verbalizzazione delle emozioni. Il trauma avrebbe inoltre ripercussioni anche sulle funzioni simboliche (Zappa et al., 2011).

In letteratura si trovano diverse definizioni di trauma. Già Sigmund Freud cercò di definirlo partendo dal concetto di due possibili origini del trauma: una da ricondurre alla realtà esterna in cui si presenta un evento che rende difficile per la persona adattarsi alla situazione e l'altra invece da ricondurre alla reazione difensiva nei confronti di pulsioni interne considerate inaccettabili. Freud stesso non soddisfatto di questa sua definizione, la rielaborò negli anni successivi. I lavori di Freud fungeranno da base per i lavori di Winnicott e Bowlby in cui viene evidenziato l'importante ruolo del caregiver e delle possibili conseguenze patologiche sullo sviluppo del bambino nel caso in cui la presa a carico e la cura risultino essere insufficienti o inadeguate (Caretto V. & La Barbera D., 2005).



Indizi di trauma. Piscine di Arzo, "Tutti dormono" – Concreta teatro. Foto L. Pezzoli, 2021.

*"Date parole al dolore:
il dolore che non parla
bisbiglia al cuore
sovraccarico
e gli ordina di spezzarsi"*

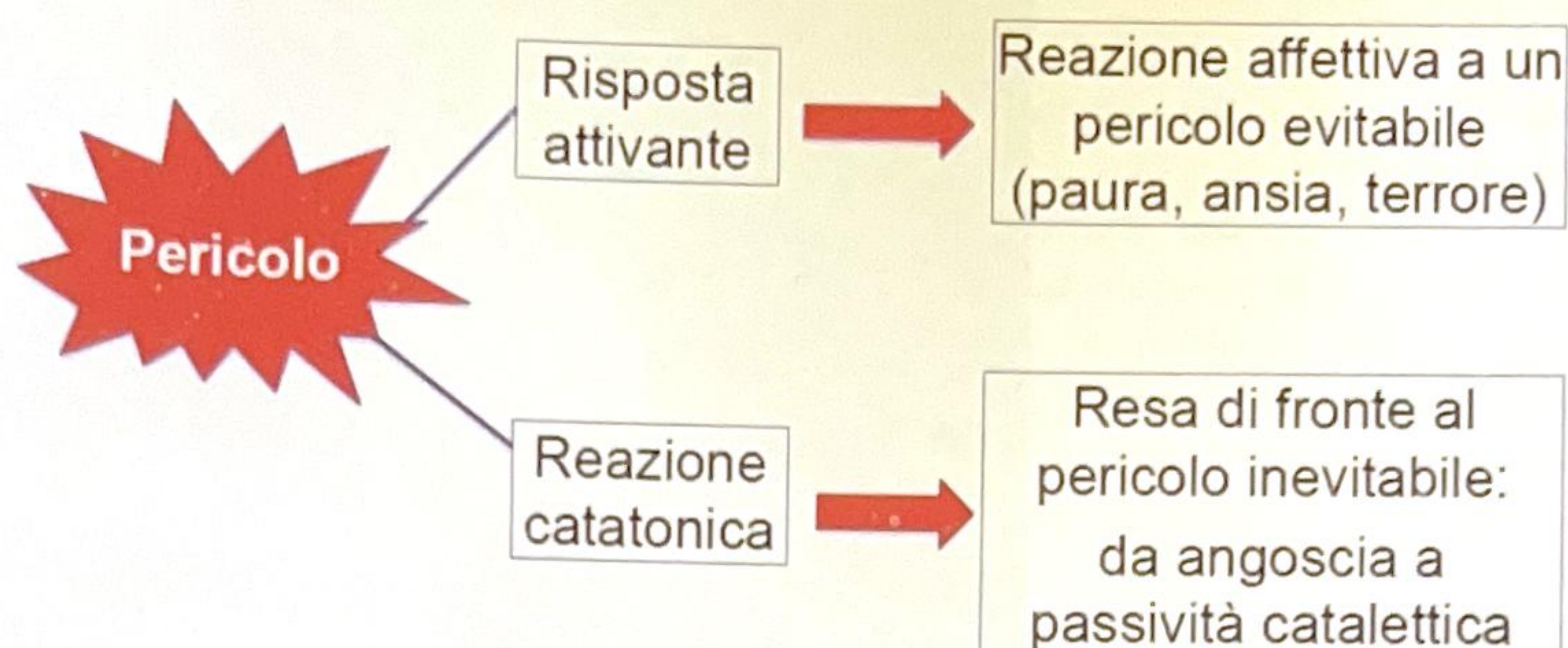
(W. Shakespeare, Macbeth atto
IV, scena III)

Krystal (1988) ha distinto due modelli di trauma psicologico: uno infantile e uno dell'età adulta. L'autore ha spiegato che il primo si manifesta attraverso un'importante angoscia che va ad influire sui precursori affettivi del bambino. Il secondo, invece, consiste in un passaggio progressivo dall'ansia alla passività catatonica. Una situazione viene definita come traumatica quando la persona ha soggettivamente l'impressione di non poter gestire la situazione, vi è dunque un vissuto di impotenza. La persona teme in questo caso per la propria o altrui integrità. Il trauma non ha tuttavia un impatto solo sull'affettività della persona ma anche sulle sue funzioni cognitive e simboliche. Nel bambino vi può essere un vissuto traumatico se il caregiver lascia che le emozioni raggiungano un livello di intollerabilità oppure nel caso in cui il processo di disillusione avviene troppo presto (si fa qui riferimento al processo di illusione e in seguito di disillusione descritti da Winnicott). Il bambino può allora faticare a distinguere tra fantasia e realtà negandone una delle due. Se il bambino nega la parte reale allora svilupperà una psicosi, se dovesse invece negare la fantasia ancorandosi esclusivamente alla realtà allora svilupperà l'alessitimia (Zappa L. E. et al., 2011).

Il trauma è stato molto studiato anche nell'adulto. Come già sottolineato da Sigmund Freud, ciò che conta non è tanto l'evento all'origine del trauma, ma l'interpretazione soggettiva che la persona ha fatto dell'evento. Ancora oggi la letteratura è concorde con questo aspetto. Le reazioni al trauma possono essere molteplici e a diversi livelli. In molti casi la persona si trova confrontata con dissociazione, depersonalizzazione, sentimento di oppressione, paralisi, inibizione cognitiva, disorganizzazione o regressione.

Secondo Krystal (2004) esistono due differenti modelli di reazione al pericolo (Zappa L. E. et al., 2011) che trovate schematizzati qui di seguito.

Modelli di risposta emotiva al pericolo secondo Krystal (elaborazione schema Cinzia Campello)



Secondo questo modello, nello stato di reazione catatonica le persone a volte non riescono a fuggire al pericolo poiché si sentono come congelate o bloccate. Molte di loro descrivono un congelamento anche a livello psichico che tocca sia le funzioni cognitive che gli affetti. Come ha spiegato Krystal (2013) paradossalmente questo congelamento degli affetti procura alla persona un senso di sollievo in quanto non sente emozioni utili, funzionali, ma nemmeno emozioni sgradevoli come la paura, il terrore o l'ansia. Queste persone vengono spesso descritte come fredde, indifferenti o razionali.

Krystal ritiene che il trauma abbia quale conseguenza una riduzione della tolleranza alle emozioni poiché vi è diniego del potenziale letale delle emozioni in quanto esse potrebbero riportare al trauma. Questi elementi in aggiunta alla regressione che riguarda sia gli affetti che gli aspetti cognitivi ed espressivi permettono di spiegare la conseguente alessitimia. L'alessitimia potrebbe essere mantenuta nel tempo se la persona non riesce ad elaborare il trauma vissuto o se il contesto di vita non lo permette (Zappa L. E. et al., 2011).

Tra le persone sopravvissute ad eventi traumatici sono stati riscontrati da diversi ricercatori dei disturbi psico-somatici (Krystal, 2013).

Alessitimia e dipendenze patologiche

Cinzia Campello

Per natura l'essere umano nasce dipendente. Il bambino alla nascita non è autosufficiente e necessita del caregiver per poter sopravvivere. Crescendo il bambino impara progressivamente a sviluppare una dipendenza sana nel senso che anche da adulto necessiterà di mantenere delle relazioni sociali all'interno delle quali poter anche esprimere le proprie emozioni. Alcune persone, tuttavia, non riescono a creare questa dipendenza sana e a mantenere la giusta distanza affettiva dagli altri. Alcune di loro cercheranno di ridurre la distanza fino a creare una relazione morbosa con l'Altro. Altre invece negheranno il bisogno di una relazione e manterranno una grande distanza affettiva dagli altri (Zappa L. E. et al., 2011).



Immagine Microsoft

Ci sono poi persone che utilizzano le sostanze psicotrope come sorta di stampella chimica per regolare le proprie emozioni. Ecco che allora le diverse sostanze verranno assunte allo scopo di aumentare o abbassare il tono dell'umore oppure con l'intenzione di non sentire un dolore. Sempre più spesso, inoltre, queste sostanze vengono combinate tra loro a volte dando origine ad altre sostanze nel corpo della persona che possono portare a effetti collaterali anche molto gravi. Ma la dipendenza patologica sappiamo bene che non è da ricondurre esclusivamente alle sostanze psicoattive (legali e illegali). A volte è il valore o il potere che viene attribuito alle sostanze (anche prive di qualsiasi elemento psicoattivo) o al comportamento messo in atto che ne fa sentire un determinato effetto ricercato. Alcune di queste dipendenze sono socialmente meglio accettate rispetto ad altre. La minor o maggior accettazione sociale di una dipendenza può dipendere da diversi elementi quali la cultura, le norme sociali, le leggi in vigore, ecc. La maggior accettazione sociale non corrisponde tuttavia a una minor pericolosità del comportamento attuato.

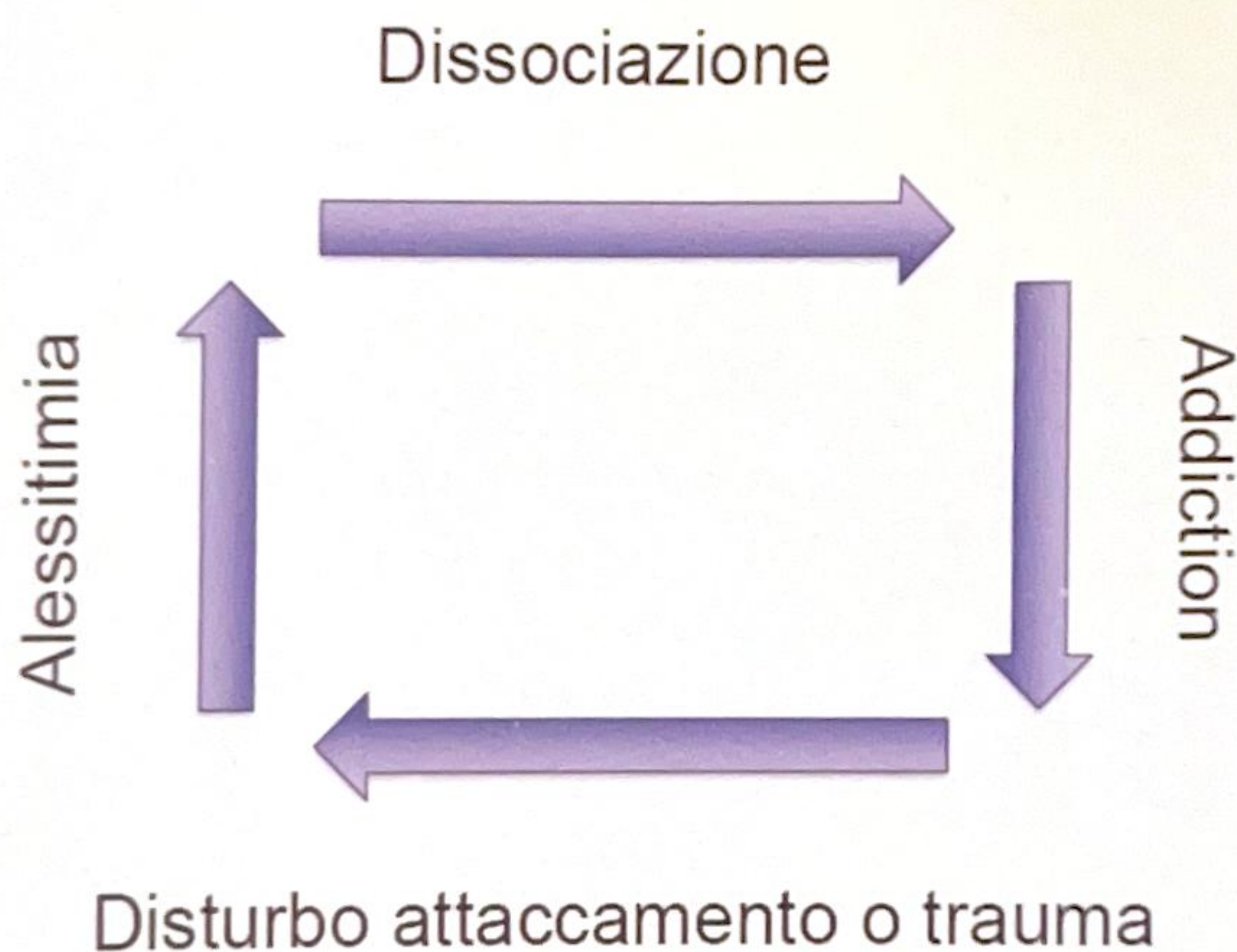
Molte ricerche sono state effettuate per comprendere l'eziologia delle dipendenze patologiche e gli studiosi sono oggi d'accordo sul definire questa eziologia come multifattoriale in quanto determinate da fattori biologici, personali e socioculturali. Diversi studi si sono anche concentrati sulla regolazione degli affetti concordando che le dipendenze patologiche trovano origine anche in un disturbo della regolazione affettiva. È stato rilevato che in generale persone che soffrono di una dipendenza da sostanze tendono a provare affetti in modo indifferenziato e prevalentemente somatico. Questi pazienti non sono capaci di verbalizzare i propri stati d'animo, né di utilizzarli nella loro funzione di segnale rispetto a sé stessi e l'ambiente in cui si trovano. La sostanza diventerebbe dunque un mezzo per bloccare in modo compulsivo le sensazioni sgradevoli provate. In particolare, Wurmser nel 1974 e poi Khantzian nel 1982 hanno descritto che per le persone che soffrono di dipendenza gli affetti difficili da regolare possono essere sia quelli intensi e dolorosi che quelli più vaghi e diffusi. La sofferenza sarebbe da ricondurre in modo particolare alla mancanza di controllo sui propri affetti. In questo senso, dunque, la persona utilizzerebbe la sostanza psico-attiva per ricavarne un beneficio. Tuttavia, svanito l'effetto ricercato della sostanza, essa porta a un peggioramento del disagio (Taylor G.J. et al., 2007).

Diversi autori tra cui Krystal e Khantzian ritengono che l'eziologia dei disturbi della regolazione affettiva sia da ricercare in relazioni disfunzionali nell'infanzia, relazioni che hanno portato a un blocco dello sviluppo emotivo. Molti ricercatori hanno infatti focalizzato la loro attenzione

sul tipo di attaccamento che questi pazienti hanno sviluppato nell'infanzia con il loro caregiver (Zappa L. E. et al., 2011). Lingiardi (2005) aveva sottolineato l'importanza dell'attaccamento sicuro per lo sviluppo futuro della persona spiegando come esso permetta di sviluppare una corretta e sana interdipendenza nelle relazioni con l'Altro.

All'interno di una relazione di sana interdipendenza la persona può poi esprimere e condividere con l'Altro le proprie emozioni e i propri sentimenti (Zappa L. E. et al., 2011). Se ripensiamo ai diversi tipi di attaccamento descritti da Bowlby (sicuro, insicuro evitante, insicuro ambivalente, disorganizzato), persone che manifestano un attaccamento morboso nei confronti dell'Altro o che al contrario ne ricercano la completa indipendenza, sono persone che nell'infanzia hanno sviluppato una forma di attaccamento di tipo insicuro. Alcuni ricercatori hanno riscontrato in pazienti dipendenti da una sostanza una forma di attaccamento insicuro evitante. Altri studi hanno invece rilevato forme di attaccamento insicuro miste (Zappa L. E. et al., 2011).

Modello psicodinamico dell'addiction (Caretto V., La Barbera D., 2005, p. 141)



Caretto et al. (2005) hanno elaborato un modello psicodinamico dell'addiction secondo il quale la persona con dipendenza da sostanze, essendo incapace di regolare le proprie emozioni, confrontata con una realtà ritenuta troppo minacciosa si rifugerebbe in modo difensivo in uno stato dissociativo tramite l'utilizzo di sostanze psico-attive.

Nel 2018 Cruise e Becerra hanno svolto una revisione di letteratura - *Alexithymia and problematic alcohol use: A critical update* – proprio su questo tema. L'obiettivo del loro lavoro è stato quello di fornire una revisione critica e aggiornata delle ricerche pubblicate sulla correlazione tra alessitimia e uso problematico di alcol. Per effettuare questa revisione di letteratura è stata condotta una ricerca sistematica attraverso i database al fine di poter ottenere letteratura rilevante pubblicata tra il 2009 e il 2016. Questo lavoro rappresenta infatti un aggiornamento dopo la precedente pubblicazione della revisione critica su questo tema svolta dai Thorberg et al. nel 2009. In questo lavoro di Cruise e Becerra sono stati inclusi gli studi che prevedevano la misurazione dell'alessitimia e uso problematico di alcol in campioni clinici e non clinici. I risultati di questa revisione aggiornata hanno potuto evidenziare una relazione indiretta tra l'alessitimia e la gravità del problema alcol-correlato, mediata da una serie di fattori psicologici relativi al consumo di alcolici. Tra questi fattori psicologici i ricercatori hanno annoverato, per esempio, i motivi alla base del consumo, il craving, ma anche i pensieri intrusivi legati all'alcol. Inoltre, questa revisione fornisce una ragionevole evidenza a sostegno

dell'alessitimia come fattore di rischio indipendente per problemi legati all'alcol solo in campioni clinici. In conclusione, gli autori dello studio spiegano che l'alessitimia è un costrutto articolato che ha una relazione complessa con diversi fattori di rischio e con il consumo di alcol. Il crescente numero di ricerche ha inoltre evidenziato la necessità di riuscire a meglio comprendere le interrelazioni tra l'alessitimia, i fattori di rischio psicosociale e l'uso problematico di alcol al fine di personalizzare e indirizzare al meglio gli interventi terapeutici.

Come si può evincere da quanto sopra, le ricerche scientifiche sul costrutto di alessitimia sono molto numerose e spaziano su numerosi diversi contesti e ben si comprende perché l'alessitimia venga ora ritenuta un costrutto transnosografico.

BIBLIOGRAFIA

- Baiocco R., Giannini A. M. e Laghi F. (2005). *SAR Scala Alessitimica Romana. Valutazione delle capacità di riconoscere, esprimere e verbalizzare le emozioni*. Trento: Erikson
- Bagby, R.M., Parker, J.D.A., Taylor, G.J. (2020). *Twenty-five years with the 20-item Toronto Alexithymia Scale*. Journal of Psychosomatic Research 131, 109940
- Caretti V., La Barbera D. (2005). *Alessitimia. Valutazione e trattamento*. Astrolabio.
- Cruise, K.E. & Becerra, R. (2018). *Alexithymia and problematic alcohol use: A critical update*. Addictive Behaviors 77, 232–246
- Fonagy, P., Gergely, G., Jurist E.L & Target, M. (2005). *Regolazione affettiva, mentalizzazione e sviluppo del Sé*. Raffaello Cortina Editore
- Haviland, M. G., Warren, W.L. & Riggs, M.L. (2020). *An Observer Scale to Measure Alexithymia*. Psychosomatics, 41:385–392
- Krystal H. (2013). *Affetto, trauma, alessitimia*. Edizioni Magi.
- Lalli N. (2005). L'alessitimia. www.nicolalilli.it
- Luminet, O., Vermeulen, N. & Grynberg, D. (2013). L'alexithymie. Comment le manque d'émotions peut affecter notre santé. De Boeck Supérieur.
- Matarazzo O., Zammuner V. L. (2015). *La regolazione delle emozioni*. Seconda edizione. Il Mulino.
- Preece, D.A., Mehta, A., Becerra, R., Chen, W., Allan, A., Robinson, K., Boyes, M., Hasking, P. & Gross J.J. (2022) *Why is alexithymia a risk factor for affective disorder symptoms? The role of emotion regulation*. Journal of Affective Disorders 296, 337–341.
- Taylor G.J., Bagby R.M., Caretti V., Schimmenti A. (2014). *La valutazione dell'alessitimia con la TSIA*. Milano: Raffaello Cortina Editore.
- Taylor G.J., Bagby R.M., Parker J.D.A. (2007). *I disturbi della regolazione affettiva. L'alessitimia nelle malattie mediche e psichiatriche*. Giovanni Fioriti Editore.
- Zappa L. E., Caslini M., Clerici M. (2011). *Le parole senza voce. Il costrutto alessitimico tra disturbi del comportamento alimentare e dipendenze*. Franco Angeli.